

	Stichwort	Was wird geprüft?	Maßnahmen
4S/SSSS	Scene	- Offensichtliche Gefahren, z.B. Strom/Elektrizität, Verkehr, Einsturz, Erdbeben, Wasser - Anzahl Patienten - Wer könnte noch betroffen sein?	Sicherung der Einsatzstelle, Eigenschutz, Abschaltung von Strom etc.
	Safety	- Gefahrenbeurteilung für Einsatzkräfte, Patienten und Dritte - Spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich?	siehe Scene
	Situation	- Art des Notfalls: Was ist passiert, Anzahl Betroffene, Welche Verletzungen? - Schweregrad der Verletzungen: Dringlichkeit der Versorgung, Ersteinschätzung Maßnahmen	Kategorisierung und Priorisierung von Patienten und Verletzungen
	Support	Weitere Einsatzkräfte? Weitere Einsatzmittel? Besondere Materialien oder Geräte?	Nachforderung von Einsatzmitteln oder Personal (z.B. Notarzt, RTW, Feuerwehr, Polizei, Schwerlast)
X	Extreme Bleeding (Extreme Blutung)	Offensichtliche kritische starke Blutungen erkennbar? Trauma: STU	Manuelle Kompression oder Druckverband, Tourniquet, Beckenschlinge, Immobilisieren (insb. Hals)
A	Airways (Atemwege)	Atemwege frei oder verlegt? Schwellung?	Ansprechen, Sichtkontrolle von Mund- und Rachenraum, ggf. Kopf überstrecken und Fremdkörper entfernen, Bei Trauma Stiffneck, Atemwegssicherung durch stabile Seitenlage oder Tubus mit Absaugbereitschaft
B	Breathing (Belüftung)	Atmung vorhanden? Atembewegungen erkennbar? Atmung ausreichend? Atemgeräusche vorhanden?	Atemkontrolle durch Hören, Sehen, Fühlen Auskultation mit Stethoskop für

		Atemarbeit ausreichend? Sauerstoffsättigung? Zyanose? Anzeichen für Lungenembolie oder Hautemphysem?	Atemfrequenz und -tiefe, Atemgeräusche (z.B. Brodeln, Pfeifen), asynchrone Atembewegung Hautfarbe checken, Pulsoximeter (Finger, Ohrläppchen, bei Kindern zum Kleben ggf. Augenbraue, möglichst rein!) —> Sauerstoffgabe, ggf. Intubation und kontrollierte Beatmung Sichtkontrolle Hals und Nacken nach gestauchten Halsvenen oder „Knisterpapier“ Allgemein Beruhigen, Unterhalten
C	Circulation (Kreislauf)	Hautfarbe und -temperatur? Recap-Zeit? Pulskontrolle Schnelle-Trauma-Untersuchung (STU) EKG Pulsbewertung Blutungen oder Frakturen erkennbar? Körpertemperatur Blutdruck auffällig?	z.B. Hände prüfen Fingernagel, Handballen drücken, <= 2sek, Pulsoximeter (belassen) EKG anschließen Tachykardie (>80bpm)/ Brachykardie (<60bpm) Sichtkontrolle/Befragung, Blutung stoppen Temperatur messen Blutdruck messen Schock: Beine hoch!
D	Disability (neurologische Defizite)	Orientierung (Raum/Zeit)? Blutzucker Weitere Auffälligkeiten/Anzeichen wie Lähmungen, Bewusstseinsstörung, Stoffwechselentgleisungen, Drogen/Alk etc.	Fragen stellen Blutzucker messen (<140 oder <100 nüchtern) Pupillenkontrolle BEFAST für Schlaganfall (Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time) Glasgow-Coma-Scale: Wach Ansprechbar - Monitoring

			Schmerz - Intubationsbereitschaft Bewusstlos - Schutzintubation Pupillenkontrolle
E	Exposure/ Environment (Erkundung)	Wärmeverlust Verletzungen Erkrankungen Anamnese: SAMPLER	Wärmeerhalt Entkleiden und Untersuchen, Bodycheck, Frakturen immobilisieren, Wundversorgung

Notarztindikation: Bewusstlosigkeit, kritische Blutung, Reanimation, MANV, Entbindung, Verdacht Herzinfarkt, Polytrauma, Suizid

Schnelle-Trauma-Untersuchung:

Einer am Kopf hält fest, prüft vom Nacken mit beiden Händen entlang der Schädeldecke bis zu den Schläfen, Handschuhe nach Blut checken, Zweiter führt weitere Untersuchungen durch: etwa am Übergang kurze Rippen seitlich drücken, von oben unterhalb Sternum auf Brustkorb drücken, Bauch abtasten ob hart, Becken seitlich drücken, Oberschenkel nacheinander auf Frakturen prüfen (eine Hand am Knie, andere Innen-/Außenseite Oberschenkel unterhalb Leiste), Patient auf die Seite drehen (Führer vom Kopf neben Rumpf und sagt an (Alternativ vom Dritten ausführen lassen), Zweiter neben Oberschenkel greift oberhalb Knie und Hüfte, Führer über Kreuz mit Griff Nr. 2 an Hüfte und Schulter), Wirbelsäule abtasten, zurückdrehen

Vorgehen im Einsatz:

1. Vorstellung und Scan Umgebung nach 4S
2. Erste Checks:
 - a. X Kritische Blutung
 - b. A Sichtkontrolle Atemwege
 - c. B Atemkontrolle (sehen, fühlen, hören)
 - d. B Hautfarbe
 - e. C Recap-Zeit
 - f. C Pulskontrolle
 - g. C STU
3. 10 for 10:
 - a. Kurze Besprechung mit Teamkollege
 - b. Einordnung in unkritisch, potentiell kritisch, kritisch
 - c. ggf. Nachforderung von Einsatzmittel oder -kräften
4. alle weiteren und umfassendere Checks aus A-E

Vorgehen im Trauma-Einsatz:

Vorstellung und Scan Umgebung nach 4S

X Kritische Blutung

A Sichtkontrolle Atemwege

B Atemkontrolle (sehen, fühlen, hören)
STU

- a. Hautfarbe
 - b. C Recap-Zeit
 - c. C Pulskontrolle
 - d. C STU
5. 10 for 10:
- a. Kurze Besprechung mit Teamkollege
 - b. Einordnung in unkritisch, potentiell kritisch, kritisch
 - c. ggf. Nachforderung von Einsatzmittel oder -kräften
6. alle weiteren und umfassendere Checks aus A-E

SAMPLER

	Stichwort	Was wird abgefragt? ggf. OPQRST-Schema
S	Symptoms	Aktuelle Symptome und Schmerzen? Akut oder Chronisch? Seit wann? Vorstellung beim Arzt? Wie hat es sich entwickelt? Ist es zwischenzeitlich besser geworden?
A	Allergies	Bekannte Allergien oder Unverträglichkeiten (Medikamente, Nahrungsmittel)
M	Medication	Welche Medikamente werden eingenommen? Regelmäßig oder Aktuell? Dosierung? Medikamentenplan!
P	Past Medical History	Vorerkrankungen? Medizinische Eingriffe? Behandlung, Medikamente? Welcher Hausarzt?
L	Last...	Letzte Mahlzeit? Wann zuletzt getrunken? Wann zuletzt Toilette? Auffälligkeiten?
E	Events	
R	Risk Factors	
S	Schwangerschaft	

(BE)FAST

	Stichwort	Was wird geprüft?	Maßnahmen
B	Balance	Ist der Gleichgewichtssinn gestört?	Person soll aufstehen und 1-2 Schritte laufen
E	Eyes		Pupillenreaktion testen: Hand über Nase halten und seitlich in die Augen leuchten, dabei Pupille im anderen Auge beobachten
F	Face		
A	Arms		
S	Speech		
T	Time	Beginn Symptome: Zeitpunkt versuchen herausfinden und vermerken für weitere Behandlung; Schnelle Reaktion und Transport in Stroke Unit im Krankenhaus (Ort nach Rücksprache Leitstelle)	